

•名老中医经验•

赵国岑教授辨治吸收不良综合征的经验

刘阿新¹, 尚学瑞²

(1. 新乡市第一人民医院, 河南 新乡 453000; 2. 辉县市中医院, 河南 辉县 453600)

关键词: 吸收不良综合征; 脾虚湿盛; 肝郁气滞; 食滞胃脘; 脾胃虚弱; 脾肾阳虚; 赵国岑
中图分类号: R574.5 文献标识码: B 文章编号: 1003-5028(2004)09-0011-02

河南省中医药研究院主任医师赵国岑是全国 500 名老中医之一, 临床 40 余年, 学验俱丰, 尤擅长消化系统疾病。笔者随其临证, 多有长进。现将其辨治消化吸收不良综合征的经验总结于下。

吸收不良综合征也称消化吸收不良综合征, 是由于各种原因引起的小肠消化吸收功能不良而使全身营养缺乏的临床症候群, 又称“脂肪泻”、“假溃疡综合征”、“溃疡样消化不良”等。本病约占国内内科门诊病人 38%, 中青年居多。其主要症状是腹泻, 粪便稀薄, 常伴有上腹部胀痛, 早饱, 餐后腹胀, 暖气恶心, 呕吐泛酸, 消瘦等, 通过测定粪便中的脂肪以及作乳糖吸收试验、胃肠 X 线检查、胰腺功能检查等其他相关检查来确诊。西医对本病缺乏持久有效的治法。

赵老认为, 本病属中医“泄泻”等范畴, 主要病因病机是饮食不节, 情志失调, 脾胃虚弱, 药物损伤等, 导致脾胃虚弱, 肝胃不和, 运化失调, 升降逆乱而成, 故治疗总以祛除病因, 调理脾胃为法。为此, 根据本病临床表现, 通常分五型论治。现分述如下。

1 脾虚湿盛型

症见胸腹胀闷, 四肢倦怠乏力, 大便溏泻, 苔腻, 脉濡缓。治宜益气健脾, 渗湿止泻。方用参苓白术散化裁。湿盛者, 酌加苍术、泽泻、厚朴等; 里寒甚腹痛者, 加干姜、肉桂。

例 1: 许某, 男, 39 岁, 职工, 2002 年 9 月 19 日就诊。诉脘腹胀闷, 大便溏泻近 3 a。经检查诊为“吸收不良综合征”, 曾服黄连素等药, 效差。昨天又因饮食不慎而旧病复发。现症: 脘腹胀闷, 四肢倦怠乏力, 大便溏泻, 苔厚腻, 质淡体胖, 脉濡缓。诊为久病脾虚, 运化失常, 水湿停留, 困扰脾土, 运化、传导、吸收功能减弱, 属脾虚湿盛。拟参苓白术散和胃苓汤加减。方药: 党参 15 g, 茯苓 20 g, 白术 10 g, 山药 15 g, 白扁豆 15 g, 砂仁 10 g, 薏苡仁 12 g, 桔梗 10 g, 苍术 12 g, 厚朴 12 g, 泽泻 15 g, 大枣 6 g。日 1 剂煎服。并嘱生活规律, 合理

饮食, 加强锻炼。患者服药 3 剂, 症状明显减轻。又随证加减服药 15 剂, 症状消失。

按: 师言, 脾气主升, 升清降浊。脾主运化, 运化水湿及水谷之精微。脾虚运化失调, 湿邪留滞, 更能伤脾, 脾更虚, 湿更盛, 清浊不分, 导致本病。故用参苓白术散以益气健脾渗湿, 用胃苓汤以助祛湿和胃, 健脾与祛湿并行, 标本同治, 因而可获良效。

2 肝郁气滞型

症见胁肋和脘腹饱、胀、痞、痛, 暖气频繁, 大便溏薄, 脉沉弦。治宜疏肝健脾, 行气解郁, 活血止痛。方用柴胡疏肝散加白术、茯苓等。加减: 若胁肋痛甚者, 酌加郁金、延胡索、当归、青皮、木香等; 有郁火者, 酌加栀子、川楝子。

例 2: 吴某, 女, 43 岁, 干部, 2003 年 6 月 8 日就诊。胃痛连及两胁, 时轻时重, 便溏 8 a 余。诊为“吸收不良综合征”。曾服香砂胃脾丸、舒肝丸等中药及吗叮啉、三九胃泰、洛赛克等西药, 获效但不持久, 失去治疗信心。近日又因工作烦恼病情加重。现症: 胃脘胀痛连及两胁, 痛时心烦不宁, 恶心, 暖气频繁, 泛酸, 纳差食少, 大便溏泻, 舌苔薄黄, 质稍暗, 脉弦紧。诊后辨为肝郁气滞, 肝胃不和。处方: 柴胡 12 g, 白芍 20 g, 枳实 10 g, 川芎 10 g, 香附 10 g, 炙甘草 6 g, 当归 12 g, 延胡索 10 g, 白术 12 g, 茯苓 20 g, 佛手 10 g。日 1 剂水煎服。5 剂后复诊, 胁痛大减, 恶心暖气泛酸及便溏症状明显好转。又按上方加减服用 17 剂, 胁痛、便溏等症状基本消失。遂改服成药香砂六君子丸合逍遥丸, 并嘱调理情志, 生活规律, 吃清淡而富有营养饮食。3 月后随访, 病情未复发。

按: 赵老认为, 肝郁气滞是导致本病的重要原因, 脾胃是受害脏腑, 因此疏肝理气, 健脾和胃是治疗本病相互依附的两个基本治法, 同时应用效果更好, 缺一则影响疗效。此例治疗汤药成药的组方均寓此义。此外, 对本型病人老师尤强调情志因素和饮食调理, 这也是取得稳定疗效的重要环节。

3 食滞胃脘型

症见腹痛腹泻, 大便稀薄而恶臭, 矢气多, 时有恶心或呕

吐,苔厚腻,脉弦实。治宜消食导滞,健脾和胃。方用保和丸加太子参、鸡内金。加减:若食滞重者,酌加枳实、大黄、泽泻等;脾胃素虚者,酌加白术等;湿盛重用茯苓。

例 3:王某,男,25 岁,工人,2002 年 8 月 12 日就诊。因饮食习惯不好,经常食后即腹痛、泄泻,反复已 3 a 余。本次因食过多饺子而发病,按“胃肠炎”、“吸收不良综合征”等治疗,效差而求治于中医。现症:胃痛,饱胀不欲食,腹痛腹泻,大便日 3~4 次,稀臭伴有不消化食物及少量油脂粘液,恶心欲呕,体瘦,苔厚腻,脉沉弦实。赵老按食滞胃脘施药,用保和丸化裁。方药:焦山楂 15 g,神曲 20 g,莱菔子 15 g,陈皮 10 g,制半夏 10 g,茯苓 25 g,连翘 10 g,太子参 15 g,鸡内金 15 g,白术 12 g。水煎服,日 1 剂。服 3 剂后复诊,对症效显。又用 5 剂,症消病愈。嘱其饮食规律,减少发病诱因。随访半年未复发。

按:本病病位在(脾)胃、肠,故最易为饮食所伤,脾胃伤则食易停滞,反更伤脾胃,久则脾胃虚弱,食不慎则病发。赵老治之既重消导和胃,更不废益气健脾,故每以保和丸为主,加甘温平淡之太子参,消食化积之鸡内金,药虽平常,却有捷效。尤其太子参、鸡内金两味,一平补脾气有益消食化积,一消食化积有益脾旺运化,二者配合,功效卓著。此外,对本型患者要特别嘱其饮食规律,减少诱因。

4 脾胃虚弱型

症见上腹部隐痛和腹泻日久不愈,反复发作,大便如油,神疲乏力,面黄消瘦。治宜健脾益气,行气温中,消食和胃。方用香砂六君子汤加减,可酌加黄芪、干姜、麦芽、谷芽、香橼等,或酌配保和丸。

例 4:张某,女,38 岁,职工,2002 年 11 月 8 日就诊。以脘腹胀闷,早饱,腹泻为主要症状,多方检查排除器质性病变,诊为“吸收不良综合征”,但遍服中西药乏效,迁延 8 a,时轻时重。现症:脘腹胀闷不舒,纳差,嗳气早饱,面黄体瘦,神疲乏力,大便次多,粘滞不利,舌苔薄,质淡,脉沉细无力。师诊曰:脾气久虚,运化失调,胃纳不佳,大肠传导失司,故作此证。属脾胃虚弱。拟方:党参 20 g,白术 10 g,茯苓 20 g,炙甘草 10 g,陈皮 10 g,半夏 10 g,木香 10 g,砂仁 10 g,黄芪 30 g,炒山药 30 g,炒麦芽 10 g,焦山楂 10 g,炒神曲 10 g。日 1 剂,水煎服。初服 10 剂,症状明显改善。又原方出入 12 剂,除乏力、纳差外,余症基本消失。后改服香砂六君子丸每次 15 g,日 3 次;配保和丸,每服 15 g,日 3 次,1 周隔日服 3 d,饭前服。时隔 1 月余,患者电话复诊诉症状消失,一切如常。又嘱其继服 1 月以巩固疗效。半年后电话随访,基本康复。

按:脾胃虚弱,贵在平调平补。香砂六君子汤能益气和胃,行气温中,是正治之方。赵老认为,本方是中药促进胃肠动力药,其中补气与行气药相配,补而不滞,使脾健胃和,肠道通利,运化有力。症状缓解后,由汤剂改服丸剂,此为治其本。更间断配服保和丸消食和胃,是启动胃肠动力开路先锋,此为治其标,如此标本兼治,巧妙配合,故常药可收非常

中国知网 <https://www.cnki.net>
• 12 •

之效。

5 脾肾阳虚型

症见腹泻日久,倦怠乏力,腰酸神疲,头晕耳鸣,畏寒肢冷,舌淡体胖,脉沉细缓。治宜温肾健脾,涩肠止泻。方用《景岳全书》胃关煎加减。腹泻或肾阳虚衰甚者,酌加补骨脂、肉豆蔻、附子等;脾虚甚者,酌加党参、白术等。

例 5:江某,男,66 岁,退休职工,2001 年 5 月 20 日就诊。患慢性腹泻已近 10 a,经胃肠镜等检查未发现器质性病变,拟诊“吸收不良综合征”,但服药时效时发,迁延不愈。现症:胃脘不舒,四肢乏力,精神倦怠,腰膝酸软,眩晕耳鸣,纳差,大便溏泄,粘腻不爽,日 3~4 次,肢体浮肿。舌质淡体胖大,苔薄,脉沉细缓,右关尺弱。诊为脾肾阳虚。方药:熟地黄 25 g,炒白术 15 g,干姜 10 g,吴茱萸 10 g,炒白扁豆 15 g,炒山药 20 g,补骨脂 10 g,煨肉豆蔻 10 g,党参 15 g,炙甘草 5 g。日 1 剂,水煎服。7 剂见效,又加减出入 21 剂,症状基本消失。改服人参健脾丸和金匮肾气丸 1 个半月,以善其后。随访半年未复发。

按:本型多见于病程较长的患者,治疗需要医患配合,耐心服药。胃关煎治疗脾肾虚寒泄泻,或久泻腹痛不止之症,赵老选作正治之方,切中病机,加用补骨脂、煨肉豆蔻以助温阳固涩,加参、附之类甘温助阳,所以见功。但要注意,一是脾肾宜同补,分量有侧重;二是应防心急速补骤温而生热生燥;三是以治本为要,开涩要恰当。

此外,赵老认为,本病有“易治易愈易复发”的特点,所以要嘱患者平时注意饮食,调畅情志,锻炼身体,以减少复发。

(编辑:魏 群)

征订启事

《广州中医药大学学报》(ISSN 1007—3213/CN 44—1425/R)是一份中医药学术类刊物。设有中医基础理论探讨、临床研究、实验研究、中药药理、中药鉴定、中药制剂与工艺、经络与针灸和疑难病案分析等栏目。本刊为双月刊,大十六开本,逢单月 20 日出版。定价:¥8.00 元/期,48.00 元/全年。邮发代号:46—275。全国各邮局均可订阅。编辑部地址:510405,广州市机场路 12 号,《广州中医药大学学报》编辑部 联系人:贺小英、袁书慧 电话:(020)36585268,36585697 传真:36585697 E-mail:gzzyxb@gzhtcm.edu.cn 网址:<http://gzzyydx-b.periodicals.net.cn>; <http://rest.china-journal.net.cn> 本编辑部存有自创刊以来的各年杂志,订价如下,款至即寄杂志及发票。合订本:1984~1985 年合订本 45.00 元,1986~1989 年每年 30.00 元,1990~1997 年每年 40.00 元,1998 年以后每年 50.00 元。单行本:1984~1996 年每期 5.00 元,1997 年每期 5.50 元,1998 年以后每期 8.00 元。